



Gitelman syndrome

จิตเทิลแมน ซินโดรม

จิตเทิลแมน ซินโดรม เป็นโรคไตทางพันธุกรรมที่พบน้อย ถ่ายทอดแบบยีนด้อย เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน *SLC12A3* ทำให้ท่อไตส่วนปลายทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่ผ่านทางปัสสาวะ ลักษณะเด่นคือภาวะ เกลือแร่ผิดปกติ โพแทสเซียมต่ำ แมกนีเซียมต่ำ และแคลเซียมในปัสสาวะต่ำ โดยมีควินิดิจัยพบในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่

สาเหตุและอาการ

- สาเหตุและกลไก: เกิดจากยีน *SLC12A3* กลายพันธุ์
- อาการทางคลินิก: ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยจนถึงปานกลาง เช่น ตะคริว, อ่อนเพลีย, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ปวดท้อง, คลื่นไส้, เวียนศีรษะ, กระจายน้ำมาก และปัสสาวะบ่อย ในเด็กจะพบภาวะน้ำหนักน้อย ตัวเล็กกว่าเพื่อน



ลักษณะทางห้องปฏิบัติการ

- ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
- ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
- ภาวะด่างในเลือดสูง
- ภาวะแคลเซียมในปัสสาวะต่ำ
- ความดันโลหิตต่ำหรือปกติ



การรักษา

รักษาตามอาการ โดยการเสริมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบยาเม็ดหรือยาน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่สูง หากไม่กินเกลือแร่เสริม มีโอกาสอ่อนเพลีย หัวใจเต้นผิดปกติ หวใจหยุดเต้น มีอันตรายถึงชีวิตได้



การปฏิบัติตัว

- การปรับเปลี่ยนอาหาร: รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูง ได้แก่กล้วย, ส้ม, อะโวคาโด, ผักโขม, ถั่ว, และปลา เพิ่มการบริโภคเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำและลดการเสียโพแทสเซียม
- รับประทานยาและเกลือแร่ (ตามแพทย์สั่ง)
- หลีกเลี่ยงการขาดน้ำ ดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวัน หากอาเจียนหรือท้องเสียรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์
- มาตรวจติดตามอาการสม่ำเสมอตามแพทย์นัด



ข้อควรระวัง

ระวังการใช้ยาที่ส่งผลต่อไตหรือยาที่ทำให้ระดับโพแทสเซียมต่ำลง และหากมีอาการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว หรือใจสั่น ควรแจ้งแพทย์ทันที

การพยากรณ์โรค

ในระยะยาวดี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุขัยปกติ แต่อาจมีคุณภาพชีวิตลดลงจากอาการเหนื่อยล้า อ่อนแรง และตะคริวเรื้อรัง แม้ภาวะไตวายจะพบได้น้อยมากแต่มีความเสี่ยงจากภาวะโพแทสเซียม/แมกนีเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยการเสริมเกลือแร่

